

Vitiligo pédiatrique : Le signe avant-coureur d'une bascule auto-immune vers une néphropathie lupique sévère

G. BOURZOUZOU^{1,2} ; T. BENCHARIF MADANI^{1,2}

¹ EHS Sidi Mabrouk, Constantine
² Université de Constantine 3, Faculté de Médecine

INTRODUCTION

L'association entre vitiligo et lupus érythémateux systémique (LES) en pédiatrie est une entité rare. Si le vitiligo est souvent considéré comme une affection auto-immune isolée, il peut parfois précéder une atteinte systémique sévère. Nous rapportons le cas d'une adolescente chez qui un vitiligo a évolué vers un LES avec néphropathie, illustrant l'importance de l'exploration immunologique.

DISCUSSION

Ce cas souligne une cascade auto-immune séquentielle. Le vitiligo a été le signe avant-coureur d'une hyperactivation systémique. L'association d'anti-ADN, d'APL et d'un C3 effondré reflète une maladie hautement active avec consommation par des complexes immuns. Ce profil biologique, témoin d'une inflammation glomérulaire intense, a justifié l'urgence d'une immunosuppression combinée agressive pour bloquer la cascade auto-immune et préserver le parenchyme rénal.

OBSERVATION

Patiente de 14 ans, présentant depuis l'âge de 10 ans un vitiligo étendu (visage et corps). Quatre ans plus tard, elle développe des lésions dermatologiques lupiques associées à une atteinte rénale (protéinurie > 0,5 mg/mg). L'exploration immunologique confirme une rupture de tolérance sévère : anticorps antinucléaires (FAN) et anti-ADN positifs, présence d'anticorps anti-phospholipides (APL), et une fraction C3 effondrée. La biopsie rénale objective une néphropathie lupique de classe III. Devant cette urgence, le traitement d'attaque a consisté en des bolus de corticoïdes (1 g/jour sur 2 jours consécutifs). Le relais a été assuré par un traitement immunosuppresseur ciblé combinant le mycophénolate mofétil (CellCept) et l'hydroxychloroquine (Plaquenil), sous couvert d'une dégression progressive de la corticothérapie orale.

CONCLUSION

Le vitiligo étendu chez l'enfant ne doit pas être banalisé comme une simple dermatose. Il peut initier un véritable continuum auto-immun. Un monitoring biologique régulier (protéinurie, complément, panel d'auto-anticorps) est indispensable pour anticiper la néphropathie lupique et instaurer une thérapie ciblée précoce, seule garante de la préservation de la fonction rénale.